

PROTOCOLO DE ACESSO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ELETIVA/ AMBULATORIAL



**JOINVILLE
2025**



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

GERÊNCIAS DE DISTRITOS SANITÁRIOS

Ana Aparecida Pereira - Distrito Norte

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann - Distrito Centro

Elisarb Mirapalhete Rodrigues Vilar - Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnathan Curcio

GERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL

Ana Caroline Giacomini

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Fabiane Voss

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaqueline Fornari

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

Nicole Schulka



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	6
1. INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÉTODO TOMOGRÁFICO.....	7
1.1. Critérios de Inclusão.....	7
1.2. Critérios de Exclusão.....	7
1.3. Grupo de Atenção.....	8
1.4. Contra Indicações.....	8
1.4.1. Contra Indicações Absolutas ao método Tomográfico com Contraste Iodado	8
1.4.2. Contra Indicações Relativas ao método Tomográfico.....	9
1.5. Critérios para Encaminhamento.....	9
1.6. Profissionais Solicitantes.....	9
1.6.1. Orientações ao Profissional Solicitante.....	9
1.7. Conteúdo Descritivo Mínimo.....	10
1.8. Pré-requisitos para realização de TC.....	10
1.9. Informações Complementares.....	10
2. SEGMENTOS - TOMOGRAFIA.....	11
2.1. TC de crânio.....	11
2.2. TC de Face ou Seios da Face.....	11
2.3. TC de pescoço.....	12
2.4. Tomografia de ouvido / ossos temporais / mastoide.....	13
2.5. Tomografia de tórax:.....	13
2.6. Tomografia de coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-sacra):.....	14
2.7. Tomografia do Abdome superior:.....	15
2.8. Tomografia do Abdome inferior:.....	16
2.9. Tomografia de pelve ou bacia sem contraste:.....	16
2.10. Tomografia das articulações:.....	17
2.11. Tomografia de Membros (direito ou esquerdo):.....	18
3. PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.....	19
4. RESULTADOS/ LAUDOS.....	19
REFERÊNCIAS.....	20



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

AASI - Aparelho de Amplificação Sonora Individual
ABR - Auditory brainstem response/Audiometria de tronco encefálico
ADNPM - Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor
APS - Atenção Primária à Saúde
BERA (ou **PEATE**) - Brainstem Evoked Response Audiometry/Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico
COMUSA - Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva
dB - Decibel
EOA - Emissões Otoacústicas Evocadas
HIJG - Hospital Infantil Joana de Gusmão
Hz - Unidade Hertz
IPRF - Índice Percentual de Reconhecimento de Fala
IRDA - Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva
KHz - KiloHertz
LDV - Limiar de Detecção de Voz
LRF - Limiar de Reconhecimento de Fala
NAIPE - Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo
Nº - Número
ORL - Otorrinolaringologia
PCD - Pessoa com Deficiência
PEATE - Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico
PFT - Prova da Função Tubária
PMV - Procedimento Municipal Vinculado
PSE - Programa de Saúde do Escolar
SASA - Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva
SC - Santa Catarina
SEI - Sistema Eletrônico de Informação
SER - Serviço Especializado em Reabilitação
SIG-SaudeTech - Sistema Integrado de Gestão
SUS - Sistema Único de Saúde
TANU - Triagem Auditiva Neonatal Universal
TDI - Transtorno do Déficit Intelectual
TDH 39 - Telephonics Dynamic Headphone Modelo 39
UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família
VRA - Audiometria de Reforço Visual
TEA - Transtorno do Espectro Autista



INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº 8.080/1990, garante o acesso universal, integral e equitativo às ações e serviços de saúde. A Política Nacional de Regulação, estabelecida pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, orienta a regulação em três dimensões: Regulação dos Sistemas de Saúde; Regulação da Atenção à Saúde e Regulação da Assistência à Saúde.

A regulação assistencial, ou regulação do acesso, consiste na disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma ordenada, oportuna, qualificada e equânime, sendo um instrumento fundamental para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Por meio do processo regulatório, promove-se a resolução de casos que exigem ações articuladas em diferentes pontos de atenção, favorecendo a gestão racional dos recursos, a identificação de áreas críticas e a otimização do atendimento.

A realização de exames de tomografia computadorizada desempenha um papel essencial no diagnóstico e tratamento de condições de saúde complexas. No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) da Prefeitura Municipal de Joinville, a utilização adequada desse exame se torna ainda mais importante, pois é um recurso avançado e, muitas vezes, de alto custo, cuja disponibilidade depende de um gerenciamento eficiente para atender às necessidades de toda a população. Uma importante organização e otimização do acesso aos exames especializados, garante que os protocolos sejam mais assertivos para os profissionais e melhor direcionados para as necessidades dos pacientes.

O objetivo do presente protocolo é firmar recomendações para os profissionais de saúde da Atenção Primária de Saúde (APS) de como funciona o fluxo ambulatorial do SUS. E também, orientar a ação dos médicos reguladores, visando criar uma cultura em que o acesso à Atenção Especializada seja determinado por necessidades reais identificadas na Atenção Primária, após esta ter esgotado toda sua capacidade de condução do caso, mas com a consciência de que a Atenção Primária em Saúde é e sempre será a responsável pelo acompanhamento de seus usuários.

1. INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÉTODO TOMOGRÁFICO

A tomografia computadorizada (TC) consiste no método de diagnóstico por imagem que através de cortes axiais que proporciona estudo detalhado de diferentes estruturas do corpo humano, facilita a localização, detecta alterações muito pequenas em ossos, tecidos, órgãos e outras estruturas do corpo e proporciona maior precisão nas intervenções clínicas e cirúrgicas.

1.1. Critérios de Inclusão

- Pacientes assistidos pela Rede Municipal de Saúde de Joinville, com indicação clínica ambulatorial justificada para exames de média e alta complexidade;
- Solicitações provenientes da APS ou da Atenção Especializada, devidamente preenchida no sistema de informação Saúde Tech e com justificativa médica;
- Exames solicitados de acordo com protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e prioridades estabelecidas (classificação de risco);
- Casos em que a realização do exame seja essencial para a definição diagnóstica e/ou para o planejamento terapêutico;

1.2. Critérios de Exclusão

- Pacientes que apresentarem instabilidade clínica (situação de saúde que necessite de atendimento de urgência);
- Solicitações de exames sem indicação clínica adequada ou ausência de justificativa médica;
- Pedidos incompletos ou com informações clínicas insuficientes no sistema de informação Saúde Tech;
- Exames solicitados em duplicidade ou já realizados recentemente sem necessidade de repetição justificada;
- Pacientes não vinculados à Rede Municipal de Saúde de Joinville;
- Procedimentos que não estão classificados na Tabela de Procedimentos do Ministério da Saúde.

1.3. Grupo de Atenção

Pacientes que necessitam de sedação e ou analgesia para realização do exame. A sedação e a analgesia são necessárias a depender das características do pedido do

exame e do paciente. A sua aplicação, quando bem indicada, viabiliza procedimentos terapêuticos ou diagnósticos oportunos e bem-sucedidos. Com a grande variedade de pacientes e suas necessidades é imprescindível individualizar a sedação e analgesia para cada situação. Isso pode ser alcançado através da avaliação detalhada durante a solicitação do exame e no pré-procedimento do paciente. Indicações de sedação para realização do exame para paciente com idade inferior a 7 anos; Desorientação e ou agitação psicomotora; Neurotípicos que tentaram realizar o exame sem sucesso; Neurodiversos não colaborativos; Claustrofobia; Ventilação mecânica por intubação orotraqueal.

1.4. Contra Indicações

Portanto, embora o método da TC em si não tenha barreiras absolutas, o uso do contraste iodado, essencial para muitos diagnósticos, possui contra indicações muito restritas.

1.4.1. Contra Indicações Absolutas ao método Tomográfico com Contraste Iodado

- a. Reação Alérgica Grave Prévia:** Pacientes que já tiveram uma reação alérgica grave (anafilática, como choque, edema de glote ou parada cardiorrespiratória) ao contraste iodado.
- b. Insuficiência Renal Grave (Doença Crônica):** Pacientes com função renal severamente comprometida (geralmente medido por uma taxa de filtração glomerular muito baixa) que *não* estão em diálise.

Importante: Pacientes nefropatas que realizam diálise devem ser avaliados pelo nefrologista assistente, para possível liberação ao uso do contraste iodado.

1.4.2. Contra Indicações Relativas ao método Tomográfico

Gravidez: Devido à radiação, a TC é evitada em gestantes, especialmente no primeiro trimestre, para proteger o feto. Contudo, se houver uma emergência médica (como suspeita de embolia pulmonar ou um trauma grave na mãe) e os benefícios superarem claramente os riscos, o exame pode ser realizado com medidas de proteção.

1.5. Critérios para Encaminhamento

Paciente com endereço comprovado na macrorregião; Diagnóstico não realizado através de outros métodos de imagem (raio x e ultrassom) de acordo com a condição clínica apresentada pelo paciente; O princípio fundamental que guia um médico para encaminhar um paciente a realização de uma TC é a justificativa clínica: o exame só deve ser pedido se a informação que ele fornecer for essencial para alterar a conduta médica, ou seja, para confirmar um diagnóstico, mudar um tratamento ou evitar um procedimento mais arriscado; Estadiamento oncológico; Pré e pós operatório; Necessário indicação clínica detalhada.

1.6. Profissionais Solicitantes

Profissional médico que compõem a rede de atenção à saúde pública do município de Joinville.

1.6.1. Orientações ao Profissional Solicitante

As solicitações de tomografia computadorizada a nível ambulatorial deverão ocorrer através no sistema Saude Tech - Olostech dentro do prontuário eletrônico na aba “Pedidos”, no item “Requisição de Procedimentos”. Em nova janela preencher CID e no campo “Pesquisar Procedimento” buscar pelo exame que deseja solicitar ex: TOMOGRAFIA. Abrirá lista dos segmentos disponíveis, selecionar o desejado e após selecionar “Condição Importante” e preencher os campos “Justificativa” e “Dados Clínicos para este Pedido”. Todas as abas referente a solicitação do exame devem ser preenchidas obrigatoriamente.

Importante: No campo “Dados Clínicos para este Pedido” deve conter as informações solicitadas no próximo tópico deste documento “**CONTEÚDO DESCRITIVO MÍNIMO**”.

1.7. Conteúdo Descritivo Mínimo

Indicação Clínica: principal motivo para solicitação do exame.

História Clínica: Comorbidades que possam indicar ou contraindicar a realização do exame, tratamentos prévios (cirurgias, quimioterapia, radioterapia, etc), existência de metais no corpo; informação de alergia, história sucinta com tempo de evolução (data do início e detalhar a história e evolução do quadro) informando se há motivos clínicos para

marcação em alta prioridade (categoria de priorização, de acordo com as tabelas de classificação de risco deste protocolo);

Exame Físico: Descrever os achados relevantes e a presença de complicações ou doenças associadas, bem como uso de medicações que possam indicar ou contraindicar a realização do exame;

Exames Complementares Prévios: Descrever laudos de exames anteriores relacionados à região a ser examinada (TC, RM, RX, exame do líquido se doença infecciosa), ou se disponíveis levar os mesmos no dia da realização do exame.

Hipótese Diagnóstica: Descrever hipótese diagnóstica no pedido médico.

Importante: Para os exames com finalidade de laudo comparativo **é obrigatório** que sejam levados os laudos anteriores.

1.8. Pré-requisitos para realização de TC

- Pedido médico preenchido adequadamente conforme “conteúdo descritivo mínimo”;
- Pacientes não colaborativos, avaliar a possibilidade de fazer a TC com sedação/anestesia geral;
- Retirar colares, anéis, pulseiras, relógios, alianças, piercings;
- Caso tenha exames anteriores da região a ser examinada, realizados em outras instituições, deverá trazê-los para comparação com o exame atual;
- Gestantes preferencialmente aguardar para fazer o exame após 12ª semana;
- Cada segmento do exame de TC dura em média 15 minutos, os pacientes devem ser colaborativos e estar cientes que não poderão se movimentar durante todo o tempo que estiver ocorrendo a aquisição das imagens.

1.9. Informações Complementares

- Para avaliação de doenças pélvicas, inclusive para avaliação neoplásica de órgãos pélvicos, a RM é o exame mais indicado.
- Para estadiamento oncológico a tomografia computadorizada do tórax e do abdome superior tem boa sensibilidade e pode substituir a ressonância;
- O exame indicado para avaliação da grande maioria das doenças pulmonares é a tomografia computadorizada (TC);

2. SEGMENTOS - TOMOGRAFIA

2.1. Tomografia de crânio

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com doença

neurológica cujo diagnóstico depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Traumatismo crânio encefálico (TCE);
- Hemorragias cerebrais;
- Tumores (diagnóstico e estadiamento);
- Metástases (detecção e acompanhamento);
- Processos Expansivos;
- Acidente vascular cerebral (AVC);
- Doenças degenerativas do encéfalo;
- Aneurismas;
- Convulsões recentes a esclarecer;
- Cefaleia grave a esclarecer;
- Hidrocefalia.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar e ou descrever laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: Médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 01. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO.

CÂNCER / SUSPEITO	Pesquisa de metástase cerebral, crise convulsiva a esclarecer de origem recente, forte suspeita de tumor cerebral, traumatismo de crânio, AVC.
P1	Aneurismas, cefaleia grave a esclarecer.
P2	Hidrocefalia.
P3	Doenças degenerativas do encéfalo.

2.2. Tomografia de Face ou Seios da Face

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Pólipos mal caracterizados por radiografia dos seios da face;
- Tumores;
- Sinusites crônicas;
- Traumatismo facial;
- Fraturas de face – acompanhamento.
- Hidrocefalia.



Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: Médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 02. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE FACE OU SEIOS DA FACE.

CÂNCER / SUSPEITO	Tumores, traumatismo facial.
P1	Pólipos mal caracterizados por radiografia dos seios da face.
P2	Sinusite crônica.
P3	Acompanhamento de fraturas da face.

2.3. Tomografia de pescoço

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Pesquisa de adenomegalia;
- Pesquisa de foco de infecção e neoplasias;
- Estadiamento dos tumores;
- Nódulo de tireoide com sintomas compressivos.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 03. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE PESCOÇO.

CÂNCER / SUSPEITO	Forte suspeita de tumor, pesquisa de foco de infecção e neoplasias
P1	Estadiamento de tumores, nódulo de tireoide com sintomas compressivos.
P2	Pesquisa de adenomegalia.

2.4. Tomografia de ouvido / ossos temporais / mastoide

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Estudo do ouvido interno;
- Estudo das mastóides;
- Perdas auditivas;
- Zumbidos no ouvido;
- Suspeita de tumores do conduto auditivo;
- Alterações vasculares;
- Malformações;
- Labirintites.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 04. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE OUVIDO / OSSOS TEMPORAIS / MASTÓIDE.

CÂNCER/ SUSPEITO	Suspeita de tumores do conduto auditivo.
P1	Estudo do ouvido interno, Estudo das mastóides Perdas auditivas, Alterações vasculares, Malformações
P2	Labirintites, Zumbidos no ouvido sem outras patologias associadas.

2.5. Tomografia de tórax:

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Traumatismo;
- Hemoptise;
- Tumores (diagnóstico e estadiamento);
- Metástases (detecção e acompanhamento);
- Nódulos não neoplásicos (avaliação e acompanhamento);
- Pneumopatias Intersticiais;
- Lesões de mediastino, hilos, pleura (avaliação);
- Bronquiectasias (acompanhamento);
- Síndrome de compressão da veia cava superior;
- Doenças da aorta (aneurisma/dissecção);
- Tromboembolismo pulmonar (TEP);
- Fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 05. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE TÓRAX.

CÂNCER/ SUSPEITO	Traumatismo, hemoptise, diagnóstico e estadiamento de tumores, TEP, dissecação de aorta, fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural.
P1	Doenças da aorta (aneurisma).
P2	Síndrome de compressão da veia cava superior, pneumopatias Intersticiais, avaliação de lesões em mediastino, hilos ou pleura, acompanhamento de tumores e metástases.
P3	Nódulos não neoplásicos (avaliação e acompanhamento), acompanhamento de bronquiectasias.

2.6. Tomografia de coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-sacra):

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Estenose do Canal Medular (suspeita);
- Fratura (suspeita/controle);
- Hérnia discal sintomática;
- Má formação congênita (hemi- vértebras);
- Metástases (detecção e acompanhamento);
- Processos expansivos;
- Tumores (diagnóstico e estadiamento);
- Processos infecciosos.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver. RX simples ou TC anterior.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 06. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE COLUNA (CERVICAL OU TORÁCICA OU LOMBAR OU LOMBO-SACRA).

CÂNCER/	Investigação de processo expansivo, suspeita de estenose de canal
----------------	---

SUSPEITO	medular, diagnóstico e estadiamento de tumor/metástases, trauma, suspeita de processo infeccioso, suspeita de fratura.
P1	Controle de processos infecciosos, neoplasias.
P2	Controle de fraturas
P3	Hérnia discal, má formação congênita (hemi-vértebras).

2.7. Tomografia do Abdome superior:

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Abscessos (suspeita/ acompanhamento);
- Dor abdominal após traumatismos;
- Tumores (diagnóstico, estadiamento e acompanhamento);
- Metástases (diagnóstico, estadiamento e acompanhamento);
- Aneurismas (diagnóstico e controle);
- Pancreatites;
- Linfonodomegalia em andar superior do abdômen (investigação e acompanhamento);
- Investigação de dor abdominal crônica em andar superior do abdômen após investigação inicial detalhada e inconclusiva.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver. RX abdômen ou TC anterior.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 07. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR.

CÂNCER/ SUSPEITO	Aneurisma sintomático, pancreatite aguda, suspeita de abscessos, dor após traumatismos, tumores (diagnóstico e estadiamento).
P1	Metástases, investigação de linfonodomegalia.
P2	Controle de abscesso, acompanhamento de tumores
P3	Controle de aneurisma, pancreatite crônica ou linfonodomegalia, investigação de dor abdominal crônica.

2.8. Tomografia do Abdome inferior:

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Abscessos (suspeita/ acompanhamento);
- Dor abdominal após traumatismos;
- Tumores (diagnóstico, estadiamento e acompanhamento);
- Metástases (diagnóstico, estadiamento e acompanhamento);
- Aneurismas (diagnóstico e controle);
- Pancreatites;
- Linfonodomegalia em andar inferior do abdômen (investigação e acompanhamento);
- Investigação de dor abdominal crônica em andar inferior do abdômen após investigação inicial detalhada e inconclusiva.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver. RX abdômen ou TC anterior.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 08. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DO ABDOME INFERIOR.

CÂNCER/ SUSPEITO	Aneurisma sintomático, pancreatite aguda, suspeita de abscessos, dor após traumatismos, tumores (diagnóstico e estadiamento).
P1	Metástases, investigação de linfonodomegalia.
P2	Controle de abscesso, acompanhamento de tumores
P3	Controle de aneurisma, linfonodomegalia, investigação de dor abdominal crônica.

2.9. Tomografia de pelve ou bacia sem contraste:

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Dor abdominal após traumatismos;
- Tumores (diagnóstico, estadiamento e acompanhamento);
- Metástases (detecção e acompanhamento);
- Avaliação/estadiamento de doenças oncológicas;
- Litíase renal ou ureteral ou vesical sintomática;
- Fístula vesical;
- Abscesso renal (suspeita e acompanhamento)

- Controle de abscessos;
- Investigação de dor pélvica crônica após investigação inicial detalhada e inconclusiva.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 09. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE PELVE OU BACIA SEM CONTRASTE.

CÂNCER/ SUSPEITO	Dor após traumatismos, diagnóstico e estadiamento de tumores, suspeita de abscessos, fístula vesical.
P1	
P2	Acompanhamento de tumores e metástases, controle de abscessos.
P3	Investigação de dor pélvica crônica, litíase renal ou ureteral ou vesical sintomática.

2.10. Tomografia das articulações:

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Dor após traumatismos;
- Tumores (diagnóstico, estadiamento e acompanhamento);
- Processos expansivos;
- Metástases (detecção e acompanhamento);
- Fraturas;
- Má formação congênita (diagnóstico e acompanhamento);
- Investigação de dor articular crônica após investigação inicial detalhada e inconclusiva.

Importante: Inclui TC de Esterno-Claviculares, Cotovelos, Sacro-Ilíaco, Coxo-Femurais, Joelhos, Tornozelo, Ombros, Coxo-Femurais Sem Contraste, Sacro-Ilíaco Sem Contraste, Cotovelos Sem Contraste, Joelhos Sem Contraste, Ombros Sem Contraste, Punhos Sem Contraste.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver - RX e/ou USG da articulação com data e laudo.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 10. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DAS ARTICULAÇÕES.

CÂNCER/ SUSPEITO	Processo expansivo, fraturas, tumores (diagnóstico, estadiamento).
P1	Má formação congênita sintomática.
P2	Acompanhamento de tumores e metástases.
P3	Investigação de dor articular crônica.

2.11. Tomografia de Membros (direito ou esquerdo):

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem.

- Dor após traumatismos;
- Tumores (diagnóstico, estadiamento e acompanhamento);
- Processos expansivos;
- Abscessos;
- Má formação congênita (diagnóstico e acompanhamento);
- Investigação de dor crônica nos membros após investigação inicial detalhada e inconclusiva.

Importante: Inclui Coxa, Coxo-Femural, Mão, Perna, Antebraço, Braço, Cotovelo, Joelho, Ombro, Pé, Punho, Tornozelo.

Descrever idade, fatores de risco, história clínica, exame físico e presença ou não de complicações ou doenças associadas. Informar laudo de exames anteriores se houver - RX e/ou USG da articulação com data e laudo.

Profissionais solicitantes: médicos da APS e médicos de outras especialidades.

Quadro 11. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ PROTOCOLO DE REGULAÇÃO - TOMOGRAFIA DE MEMBROS.

CÂNCER/ SUSPEITO	Processo expansivo, tumores (diagnóstico, estadiamento), abscessos.
P1	Má formação congênita sintomática.
P2	Acompanhamento de tumores e metástases.
P3	Investigação de dor crônica.



3. PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME

O preparo para realização do exame é orientado pelo prestador do serviço ao usuário.

4. RESULTADOS/ LAUDOS

Os laudos devem ser retirados pelo usuário ou representante legal do mesmo, conforme orientação do prestador do exame. Respeitando a LGPD.



REFERÊNCIAS

CATARINA, Ses-Secretaria do Estado de Santa. EXAMES ADULTO : Protocolo de Tomografia. Disponível em:

<https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/regulacao/protocolo-de-acesso-e-classificacao-d-e-risco/exames-adulto?start=0>. Acesso em: 07 out. 2025.

<https://portais.santoandre.sp.gov.br/saude/wp-content/uploads/sites/30/2025/06/PROTOCOLO-DE-ACESSO-EXAMES-APROVADO.pdf>

